

transcribed_pregunta6.pdf

0 – 14.1

En las seis, estamos en las seis, ¿vale? Bueno, sí, considero que adaptar la dificultad según la edad es relevante tanto clínica como psicopedagógicamente, porque aunque

14.1 – 26.6

los déficits de atención pueden aparecer en todos los rangos de edad, la manifestación y el nivel de exigencia que puede afrontar el niño cambia significativamente a medida

26.6 – 40.6

que el cerebro va madurando. Entonces, desde una perspectiva neurológica, las funciones ejecutivas dependen en gran medida del desarrollo de la corteza prefrontal, una región que

40.6 – 52.3

continúa madurando durante la infancia y la adolescencia. Entonces, un niño de cuatro años tiene una capacidad atencional, una memoria de trabajo y un control inhibitorio naturalmente más limitados que un niño de ocho o nueve años, independientemente de

52.3 – 69

que los dos tengan TDA. Entonces, evaluar o entrenar todos con el mismo nivel de dificultad produciría resultados poco válidos, ¿no? Una experiencia inadecuada para muchos de los niños que lo utilicen. Entonces, por esta razón, la división entre

69 – 83.4

rangos de edad está justificada. En un primer nivel de tres a cinco años deben predominar instrucciones muy simples, estímulos visuales claros y demandas reducidas de memoria y autocontrol. En el segundo nivel de cinco a siete años, pues ya podemos aumentar gradualmente

83.4 – 94.7

la cantidad de información a procesar, la duración de las tareas y la necesidad de seguir reglas, ¿no? Y luego ya, pues de siete a diez años, podemos incorporar ya secuencias

94.7 – 105.9

mucho más largas, con mayor velocidad de respuesta, distractores más complejos, desafíos que requieran un poquito ya de planificación y algo que nos marque un sistema más avanzado

105.9 – 116

de control inhibitorio. Entonces, bueno, yo creo que por eso el proyecto nunca se debe plantear como un juego único para todos porque un juego de estas características no se puede

116 – 129.5

plantear ni entender al margen de un desarrollo evolutivo. Entonces, el objetivo es que cada niño trabaje las mismas funciones cognitivas que están afectadas por el trastorno que padece pero mediante retos adaptados a sus capacidades madurativas. Entonces, esta personalización

129.5 – 140.9

lo que va a aumentar es siempre la eficacia del entrenamiento, la mejora de la motivación y va a favorecer a que haya un verdadero, a que la intervención tenga un verdadero

140.9 – 143

valor terapéutico y educativo.